Rx **AREXVY**

Vắc xin vi rút hợp bào hô hấp (RSV) (tái tổ hợp, được bổ trợ với $AS01_E$)

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc.

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

THÀNH PHẦN ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG

Thành phần hoạt chất

Sau khi hoàn nguyên, 1 liều (0,5 mL) chứa 120 microgram kháng nguyên RSVPreF3[1] được bổ trợ với $AS01_E$[2]

[1] Glycoprotein F của virus hợp bào hô hấp (RSV) ổn định ở dạng tiền hợp nhất RSVPreF3, được sản xuất bằng kỹ thuật ADN tái tổ hợp từ tế bào buồng trứng của chuột Hamster Trung Quốc (CHO)

[2] Hệ thống bổ trợ $AS01_E$ độc quyền của GlaxoSmithKline gồm chất chiết xuất từ cây *Quillaja saponaria* Molina, phân đoạn 21 (QS-21) (25 microgram) và 3-O-desacyl-4'-monophosphoryl lipid A (MPL) từ *Salmonella minnesota* (25 microgram)

Thành phần tá dược:

Bột (kháng nguyên RSVPreF3):

Trehalose dihydrate

Polysorbate 80

Potassium dihydrogen phosphate

Dipotassium phosphate

Hỗn dịch (Hệ thống bổ trợ $AS01_E$):

Dioleoyl phosphatidylcholine

Cholesterol

Sodium chloride

Disodium phosphate, dạng khan

Potassium dihydrogen phosphate

Nước cất pha tiêm

DẠNG BÀO CHẾ

Bột và hỗn dịch để pha hỗn dịch tiêm.

Bột có màu trắng.

Hỗn dịch là một chất lỏng đục, không màu đến nâu nhạt.

CHỈ ĐỊNH

Arexvy được chỉ định để tiêm ngừa chủ động cho người lớn ≥60 tuổi, dự phòng các bệnh đường hô hấp dưới (LRTD) do vi-rút hợp bào hô hấp phân nhóm RSV-A và RSV-B gây ra.

Việc sử dụng Arexvy nên dựa theo các khuyến cáo chính thức.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Việc sử dụng Arexvy nên dựa theo các khuyến cáo chính thức.

Liều lượng

Tiêm Arexvy với một liều duy nhất 0,5 mL. Sự cần thiết của việc tiêm chủng nhắc lại chưa được thiết lập.

Cách dùng

Arexvy chỉ được dùng qua đường tiêm bắp, tốt nhất là ở vùng cơ delta.

Xem hướng dẫn hoàn nguyên sản phẩm trước khi tiêm tại mục *Sử dụng và Xử lý*.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn với các thành phần hoạt tính hoặc bất kỳ thành phần nào của vắc xin (xem *Dạng bào chế, Thành phần định tính và định lượng*).

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

Trước chủng ngừa

Giống như các vắc xin tiêm khác, nên chuẩn bị sẵn các phương tiện điều trị và theo dõi thích hợp trong trường hợp xảy ra phản ứng phản vệ xảy ra sau khi tiêm vắc xin.

Cũng như các vắc xin khác, nên hoãn tiêm Arexvy cho những người đang sốt cao cấp tính. Tuy nhiên, không hoãn tiêm chủng cho các biểu hiện nhiễm trùng nhẹ, như cảm lạnh.

Cũng như bất kỳ vắc xin khác, đáp ứng miễn dịch bảo vệ có thể không xuất hiện ở tất cả các đối tượng được tiêm vắc xin.

Ngất (bất tỉnh) có thể xảy ra sau khi tiêm hoặc thậm chí trước khi tiêm do phản ứng tâm lý đối với kim tiêm. Quan trọng là phải có các biện pháp xử lý tại chỗ để tránh thương tích do ngất.

Thận trọng khi sử dụng

Không tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm trong da. Arexvy chưa có dữ liệu tiêm dưới da.

Cũng như các vắc xin khác dùng đường tiêm bắp, nên thận trọng khi sử dụng Arexvy cho những người bị giảm tiểu cầu hoặc bất kỳ rối loạn đông máu nào vì có thể xuất hiện chảy máu sau khi tiêm bắp cho những đối tượng này.

Các thuốc ức chế miễn dịch toàn thân và tình trạng suy giảm miễn dịch

Chưa có dữ liệu về tính an toàn và tính sinh miễn dịch của Arexvy ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch. Bệnh nhân đang điều trị các thuốc ức chế miễn dịch hoặc bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch có thể bị giảm đáp ứng miễn dịch với Arexvy.

THAI KỲ VÀ CHO CON BÚ

Khả năng sinh sản

Không có dữ liệu lâm sàng về ảnh hưởng của Arexvy đối với khả năng sinh sản. Chưa có đánh giá về ảnh hưởng lên khả năng sinh sản của con đực và con cái trong các nghiên cứu trên động vật.

Thai kỳ

Không có dữ liệu về việc sử dụng AREXVY ở phụ nữ mang thai. Không khuyến cáo sử dụng AREXVY trong thai kỳ.

Sau khi tiêm vắc xin RSVPreF3 loại khảo sát và không có chất bổ trợ cho 3.557 phụ nữ mang thai trong một thử nghiệm lâm sàng duy nhất, ghi nhận tỉ lệ sinh non cao hơn so với nhóm tiêm giả dược.

Cho con bú

Không có dữ liệu về việc Arexvy bài tiết vào sữa mẹ hoặc sữa của động vật. Không khuyến cáo sử dụng Arexvy ở phụ nữ đang trong thời kỳ cho con bú/nuôi con bằng sữa mẹ.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Hiện chưa có nghiên cứu về ảnh hưởng của Arexvy đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC VÀ TƯƠNG KỴ

Sử dụng với các loại vắc xin khác:

Có thể tiêm đồng thời Arexvy với vắc xin cúm mùa bất hoạt (xem *Các tác dụng dược lực*).

Nếu dùng Arexvy đồng thời với vắc xin đường tiêm khác, nên tiêm các vắc xin ở những vị trí khác nhau.

Tương kỵ

Không được trộn Arexvy với các sản phẩm y khoa khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Hồ sơ an toàn được trình bày dưới đây dựa trên một nghiên cứu lâm sàng Pha III có đối chứng giả dược (được tiến hành ở Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Á và Nam Bán cầu) ở các đối tượng người lớn ≥ 60 tuổi trong đó 12.467 đối tượng được tiêm một liều Arexvy và 12.499 đối tượng được tiêm giả dược.

Các phản ứng bất lợi được liệt kê dưới đây theo hệ thống cơ quan của cơ thể (MedDRA) và tần suất.

Rất phổ biến ≥1/10

Phổ biến ≥1/100 đến < 1/10

Không phổ biến ≥1/1.000 đến < 1/100

Hiếm ≥1/10.000 đến < 1/1.000

Rất hiếm < 1/10.000

Phân loại theo hệ cơ quan	**Tần suất**	**Các tác dụng không mong muốn**
Rối loạn máu và hệ bạch huyết	Không phổ biến	Sưng hạch bạch huyết
Rối loạn hệ miễn dịch	Không phổ biến	Phản ứng quá mẫn (phát ban)
Rối loạn hệ thần kinh	Rất phổ biến	Đau đầu
Rối loạn hệ hô hấp, lồng ngực và trung thất	Phổ biến	Chảy mũi
Rối loạn tiêu hóa	Không phổ biến	Buồn nôn, đau bụng
Rối loạn cơ xương và mô liên kết	Rất phổ biến	Đau cơ, đau khớp
Rối loạn toàn thân và tình trạng tại vị trí tiêm	Rất phổ biến	Đau tại vị trí tiêm, mệt mỏi
	Phổ biến	Phản ứng tại vị trí tiêm (ban đỏ, sưng), sốt, ớn lạnh
	Không phổ biến	Ngứa tại vị trí tiêm
		Đau, khó chịu

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ nếu có các phản ứng bất lợi xảy ra trong quá trình sử dụng.

QUÁ LIỀU

Không có dữ liệu đầy đủ về sử dụng quá liều.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ

Dược lực học

Mã ATC: J07BX05

Cơ chế hoạt động

Nguy cơ phát triển các bệnh đường hô hấp dưới do RSV gây ra gia tăng theo độ tuổi và theo sự hiện diện của các bệnh nền đồng mắc. Arexvy kích hoạt các đáp ứng miễn dịch dịch thể chức năng

chống lại phân nhóm RSV-A và RSV-B và các đáp ứng miễn dịch tế bào đặc hiệu với kháng nguyên, các đáp ứng này góp phần bảo vệ ngăn ngừa các bệnh đường hô hấp dưới do RSV gây ra (xem phần *Tính sinh miễn dịch của Arexvy*).

Trong một thử nghiệm lâm sàng Pha I/II, công thức có chất bổ trợ $AS01_E$ cho thấy khả năng khôi phục lượng tế bào T CD4+ đặc hiệu với RSVPreF3 ở các đối tượng người lớn từ 60 đến 80 tuổi đạt đến mức tương đương với mức của các đối tượng trưởng thành trẻ tuổi hơn, mặc dù mức cơ bản có lúc ban đầu thấp hơn.

Dữ liệu phi lâm sàng cho thấy $AS01_E$ tạo ra sự kích hoạt hệ miễn dịch bẩm sinh cục bộ và tạm thời thông qua các con đường phân tử đặc hiệu. Tác dụng bổ trợ của $AS01_E$ là kết quả của các tương tác giữa MPL và QS-21 được tạo thành trong liposome. Điều này tạo điều kiện thu hút và kích hoạt các tế bào trình diện kháng nguyên, đang mang kháng nguyên có nguồn gốc từ vắc xin trong hạch bạch huyết dẫn lưu, từ đó tạo ra các tế bào T CD4+ đặc hiệu với RSVPreF3 và kích hoạt đáp ứng của kháng thể để trung hòa RSV-A và RSV-B. Ngoài ra, công thức RSVPreF3 có chất bổ trợ $AS01_E$ có thể tạo ra các kháng thể có khả năng gắn kết đặc hiệu và trực tiếp với vị trí Ø, một epitope nhạy cảm có khả năng trung hòa cao, chỉ được bộc lộ ở dạng tiền hợp nhất của protein F.

Các tác dụng dược lực

1. Hiệu lực của Arexvy

Hiệu lực của Arexvy phòng ngừa các bệnh đường hô hấp dưới do RSV ở các đối tượng người lớn ≥60 tuổi đã được đánh giá trong nghiên cứu RSV OA=ADJ-006, một nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên, mù đơn (giám sát viên), có đối chứng giả dược, Pha III tiến hành tại 17 quốc gia ở Bắc và Nam Bán cầu. Các đối tượng tham gia nghiên cứu được lên kế hoạch theo dõi lên đến 36 tháng.

Nhóm dân số chính để phân tích hiệu lực (nhóm phơi nhiễm đã được hiệu chỉnh, bao gồm các đối tượng người lớn ≥60 tuổi được tiêm 1 liều Arexvy hoặc giả dược và không mắc các bệnh hô hấp cấp (ARI) do RSV gây ra trước Ngày 15 sau khi tiêm chủng được báo cáo, bao gồm 24.960 đối tượng tham gia nghiên cứu, được phân ngẫu nhiên thành 2 nhóm tương đương nhau và được tiêm 1 liều Arexvy (N = 12.466) hoặc giả dược (N = 12.494). Ở thời điểm phân tích hiệu lực chính, các đối tượng tham gia nghiên cứu đã được theo dõi sự phát triển bệnh đường hô hấp dưới do RSV gây ra trong tối đa 10 tháng (trung vị là 6,7 tháng).

Tại thời điểm ban đầu, 39,3% đối tượng tham gia nghiên cứu có ít nhất một bệnh đồng mắc cần quan tâm; 19,7% đối tượng có bệnh nền về tim phổi (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen, bất kỳ bệnh lý đường hô hấp/phổi mạn tính nào, hoặc suy tim mạn tính) và 25,8% đối tượng mắc các bệnh chuyển hóa nội tiết (đái tháo đường, bệnh gan hoặc thận tiến triển).

Sau khi thử nghiệm tốc độ di chuyển (Gait speed test), có 38,3% đối tượng tham gia nghiên cứu được xếp vào nhóm tiền suy nhược (tốc độ bước đi 0,4-0,99 m/giây) và 1,5% được xếp vào nhóm suy nhược (tốc độ bước đi < 0,4 m/giây hoặc không thể thực hiện thử nghiệm).

<u>Hiệu lực chống lại bệnh đường hô hấp dưới do RSV gây ra</u>

Tiêu chí chính là chứng minh hiệu lực của Arexvy trong việc dự phòng đợt bệnh đường hô hấp dưới đầu tiên, có xác nhận là do RSV-A và/hoặc B gây ra, trong suốt mùa bệnh đầu tiên.

Các ca nhiễm RSV được xác nhận bằng kỹ thuật qRT-PCR (quantitative Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) trên dịch phết mũi họng. Bệnh đường hô hấp dưới được xác định dựa trên các tiêu chí sau: đối tượng tham gia phải có ít nhất 2 dấu hiệu/triệu chứng của đường hô hấp dưới trong đó ít nhất 1 dấu hiệu của đường hô hấp dưới kéo dài trong ít nhất 24 giờ, hoặc có ít nhất 3 triệu chứng của đường hô hấp dưới trong ít nhất 24 giờ. Các triệu chứng của đường hô hấp dưới bao gồm: khạc đàm hoặc tăng tiết đàm, xuất hiện ho hoặc ho nhiều hơn, xuất hiện khó thở hoặc khó thở nhiều hơn (hụt hơi). Các dấu hiệu đường hô hấp dưới bao gồm: xuất hiện khò khè hoặc tăng khò khè, có ran nổ/ran ngáy, nhịp thở ≥20 nhịp/phút, độ bão hòa oxy thấp hoặc giảm (độ bão hòa oxy < 95% hoặc ≤90 % nếu độ bão hoà oxy ban đầu < 95%) hoặc cần bổ sung oxy.

So với giả dược, Arexvy làm giảm có ý nghĩa nguy cơ phát triển bệnh đường hô hấp dưới do RSV gây ra, với hiệu lực 82,58% (Khoảng tin cậy (CI) 96,95%: [57,89; 94,08]) ở những đối tượng tham gia nghiên cứu ≥60 tuổi, các đối tượng này đạt các tiêu chuẩn được định nghĩa trước trong tiêu chí chính của nghiên cứu (Bảng 1). Trong khoảng thời gian theo dõi trung vị 6,7 tháng, vắc xin có hiệu lực cao chống lại bệnh đường hô hấp dưới do RSV gây ra đã được quan sát.

Hiệu lực của vắc xin phòng chống các ca bệnh đường hô hấp dưới do RSV A và RSV B gây ra lần lượt là 84,62% (CI 95% [32,08; 98,32]) và 80,88% (CI 95% [49,40; 94,27]).

Bảng 1. Phân tích hiệu lực: Dân số chung mắc bệnh đường hô hấp dưới do RSV gây ra trong đợt đầu tiên, phân nhóm theo độ tuổi và theo bệnh đồng mắc trong nghiên cứu RSV OA=ADJ-006 (nhóm phơi nhiễm đã được hiệu chỉnh)

Phân nhóm	AREXVY			Giả dược			% Hiệu lực (CI)[a]
	N	n	Tỉ lệ mắc trên 1.000 Năm-Người	N	n	Tỉ lệ mắc trên 1.000 Năm-Người	
Dân số chung (≥60 tuổi)[b]	12466	7	1,0	12494	40	5,8	82,58 (57,89; 94,08)
60-69 tuổi	6963	4	1,0	6979	21	5,5	80,96 (43,56; 95,25)
70-79 tuổi	4487	1	0,4	4487	16	6,5	93,81 (60,15; 99,85)
Số đối tượng tham gia có ít nhất 1 bệnh	4937	1	0,4	4861	18	6,6	94,61 (65,88; 99,87)

đồng mắc cần quan tâm							

[a]CI = Khoảng tin cậy (CI 96,95% áp dụng cho dân số chung (≥60 tuổi) và CI 95% áp dụng cho các phân nhóm còn lại). Độ chính xác của CI 2 phía đối với hiệu lực của vắc xin được lấy dựa trên mô hình Poisson đã hiệu chỉnh theo nhóm tuổi và khu vực.

[b]Xác nhận đạt tiêu chí chính theo các tiêu chuẩn đã được định nghĩa trước, với ngưỡng giới hạn dưới của CI 2 phía đối với hiệu lực vắc xin >20%

N = Số đối tượng tham gia nghiên cứu được tuyển vào trong mỗi nhóm

n = Số đối tượng tham gia nghiên cứu được xác nhận lần đầu tiên mắc bệnh đường hô hấp dưới do RSV từ Ngày 15 sau khi tiêm chủng

So với giả dược, Arexvy làm giảm có ý nghĩa nguy cơ phát triển bệnh đường hô hấp dưới do RSV gây ra, với hiệu lực 84,37% (CI 95%: [46,91; 97,04]) ở các đối tượng người lớn ≥70 tuổi. Không thể kết luận hiệu lực của vắc xin trong phân nhóm ≥80 tuổi (1016 đối tượng ở nhóm Arexvy so với 1028 đối tượng ở nhóm giả dược) do tổng số ca tích lũy thấp (5 ca).

So với giả dược, Arexvy làm giảm có ý nghĩa nguy cơ phát triển bệnh đường hô hấp dưới do RSV gây ra ở đối tượng tiền suy nhược, với hiệu lực 92,92% (CI 95% [53,44; 99,83]). Không thể kết luận hiệu lực của vắc xin ở phân nhóm suy nhược (189 đối tượng ở nhóm Arexvy so với 177 đối tượng ở nhóm giả dược) do tổng số ca tích lũy thấp (2 ca).

<u>Hiệu lực chống lại bệnh đường hô hấp dưới mức độ nặng do RSV và bệnh hô hấp cấp do RSV</u>

Trong nghiên cứu RSV-OA=ADJ-006, bệnh đường hô hấp dưới mức độ nặng do RSV được định nghĩa là các bệnh đường hô hấp dưới đã xác nhận do RSV bằng kỹ thuật RT-PCR với ít nhất 2 dấu hiệu của đường hô hấp dưới, hoặc có một đợt bệnh đường hô hấp dưới được xác nhận bằng kỹ thuật RT-PCR do RSV gây ra và được nghiên cứu viên đánh giá là 'nặng'. Kết quả có một ca bệnh đường hô hấp dưới mức độ nặng do RSV ở nhóm Arexvy và 17 ca ở nhóm giả dược, trong đó có 2 ca cần điều trị hỗ trợ.

So với giả dược, Arexvy làm giảm có ý nghĩa nguy cơ phát triển bệnh đường hô hấp dưới mức độ nặng do RSV, với hiệu lực 94,10 % (CI 95% [62,37; 99,86]) ở các đối tượng người lớn ≥60 tuổi.

Bệnh hô hấp cấp được định nghĩa là có sự hiện diện ít nhất 2 triệu chứng/dấu hiệu của đường hô hấp trong ít nhất 24 giờ, hoặc ít nhất 1 triệu chứng/dấu hiệu của đường hô hấp + 1 triệu chứng/dấu hiệu toàn thân (sốt hoặc có triệu chứng sốt, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, đau đầu, giảm cảm giác thèm ăn) trong ít nhất 24 giờ. Arexvy làm giảm có ý nghĩa nguy cơ phát triển bệnh hô hấp cấp được xác nhận do RSV gây ra ở các đối tượng người lớn ≥60 tuổi, giảm 71,71% (CI 95% [56,23; 82,27])

Kết quả theo báo cáo của bệnh nhân

Nghiên cứu Arexvy so với giả dược (RSV OA=ADJ-006) đã đánh giá định lượng mức giảm cường độ của các triệu chứng đường hô hấp bằng cách để bệnh nhân tự báo cáo thông qua bảng câu hỏi FLU-PRO. Sau khi khảo sát qua bảng câu hỏi FLU-PRO ở các đối tượng có một đợt bệnh hô hấp cấp được xác nhận do RSV gây ra, kết quả cho thấy nhóm sử dụng Arexvy làm giảm có ý nghĩa cường độ các triệu chứng đường hô hấp dưới do RSV gây ra một khác biệt có ý nghĩa lâm sàng so với nhóm sử dụng giả dược khi đánh giá thông qua điểm số tối đa ở tiêu chí lồng ngực trong bảng câu hỏi FLU-PRO (phạm vi thang điểm: từ 0-4 điểm) sau 7 ngày đầu tiên của đợt bệnh (Trung bình [độ lệch chuẩn] là 1,32 [1,02] ở nhóm Arexvy so với 1,90 [0,93] ở nhóm giả dược).

2. Tính sinh miễn dịch của Arexvy

Chưa thiết lập được mối tương quan miễn dịch về khả năng bảo vệ; do đó, mức độ đáp ứng miễn dịch bảo vệ chống lại bệnh đường hô hấp dưới do RSV vẫn chưa rõ.

Các đáp ứng miễn dịch với Arexvy đã được đánh giá trong nghiên cứu Pha III RSV OA=ADJ-004, về tính an toàn và tính sinh miễn dịch ở các đối tượng người lớn ≥60 tuổi. Các đáp ứng miễn dịch dịch thể chức năng sau khi tiêm chủng so với trước khi tiêm chủng được đánh giá kết quả từ 940 đối tượng ở nhóm RSV-A và 941 đối tượng ở nhóm RSV-B tại tháng thứ 1 so với trước khi tiêm chủng, và 928 đối tượng ở nhóm RSV-A và 929 đối tượng ở nhóm RSV-B tại tháng thứ 6 so với trước khi tiêm chủng. Thực hiện đánh giá đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào dựa trên kết quả của 471 đối tượng trước khi tiêm chủng, 410 đối tượng ở tháng thứ 1 và 440 đối tượng ở tháng thứ 6.

Arexvy tạo ra các đáp ứng miễn dịch tế bào và miễn dịch dịch thể đặc hiệu với RSV. Mức tăng trung bình nhân của các hiệu giá trung hòa RSV-A và RSV-B so với trước khi tiêm chủng lần lượt là 10,5 lần (CI 95% [9,9; 11,2]) và 7,8 lần (CI 95% [7,4; 8,3]) tại thời điểm một tháng sau khi tiêm chủng, và lần lượt là 4,4 lần (CI 95% [4,2; 4,6]) và 3,5 lần (CI 95% [3,4; 3,7]) tại thời điểm 6 tháng sau khi tiêm chủng. Trung vị tần suất (bách phân vị thứ [25, 75]) của tế bào T CD4+ đặc hiệu với RSVPreF3 (trên một triệu tế bào T CD4+) là 1339,0 (829,0; 2136,0) tại thời điểm 1 tháng sau khi tiêm chủng và 666,0 (428,0; 1049,5) tại thời điểm 6 tháng sau khi tiêm chủng so với 191,0 (71,0; 365,0) trước khi tiêm chủng.

Tính sinh miễn dịch ~~sau~~ khi tiêm chủng đồng thời

Trong một nghiên cứu lâm sàng Pha III nhãn mở, các đối tượng tham gia nghiên cứu ≥60 tuổi đã được tiêm 1 liều vắc xin Arexvy và 1 liều vắc xin cúm mùa bất hoạt (vắc xin cúm tứ giá kết hợp chứa tổng cộng 60 microgram Hemagglutinin (HA) trong mỗi liều) vào tháng 0 (N = 442), hoặc 1 liều cúm tứ giá vào tháng 0, sau đó là một liều Arexvy vào tháng 1 (N = 443).

Không có bằng chứng cho thấy có sự cản trở đáp ứng miễn dịch với bất kỳ kháng nguyên nào có trong cả hai loại vắc xin khi được tiêm đồng thời. Các tiêu chuẩn về tính không thua kém của các đáp ứng miễn dịch trong nhóm chứng so với nhóm được tiêm đồng thời đã được đáp ứng khi

ngưỡng giới hạn trên của khoảng tin cậy 95% hai phía của tỉ số hiệu giá kháng thể trung bình nhân ở hai nhóm đều < 1,50 đối với các kháng thể trung hòa RSV-A cũng như các kháng thể ức chế haemagglutinin chống lại các chủng Cúm A/Cúm Hong Kong/Cúm H3N2, Cúm A/Cúm Victoria/Cúm H1N1, Cúm B/Cúm Phuket/Cúm Yamagata và Cúm B/Cúm Washington/Cúm Victoria.

Dược động học

Không yêu cầu đánh giá đặc tính dược động học cho vắc xin.

THÔNG TIN PHI LÂM SÀNG

Dữ liệu phi lâm sàng cho thấy không có mối nguy hiểm đặc biệt nào đối với con người dựa trên các nghiên cứu chung về tính an toàn.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Quy cách đóng gói:

Hộp gồm 1 lọ bột chứa 120 mcg kháng nguyên RSVPreF3 và 1 lọ chứa 0,5 mL hỗn dịch chất bổ trợ $AS01_E$.

Bột đủ cho 1 liều, đựng trong lọ (thủy tinh loại I) có nút chặn (cao su butyl).

Hỗn dịch đủ cho 1 liều, đựng trong lọ (thủy tinh loại I) có nút chặn (cao su butyl).

Bảo quản

Bảo quản trong tủ lạnh (2°C – 8°C).

Không để đông đá.

Giữ nguyên trong bao bì đóng gói của nhà sản xuất để tránh ánh sáng.

Xem cách bảo quản sau khi hoàn nguyên trong mục *Sử dụng và Xử lý*.

Hạn dùng:

Hạn dùng lọ bột kháng nguyên: 24 tháng, lọ hỗn dịch chất bổ trợ: 36 tháng (kể từ ngày sản xuất). Ngày hết hạn của thành phẩm là ngày hết hạn của thành phần có ngày hết hạn đến trước.Để biết thời hạn sử dụng của sản phẩm sau khi hoàn nguyên, xem phần *Sử dụng và Xử lý*.

Sử dụng và Xử lý

Nên kiểm tra bột và hỗn dịch bằng mắt thường xem có bất kỳ phân tử lạ và/hoặc biến đổi nào về mặt vật lý hay không. Nếu có bất kỳ vấn đề nào nêu trên, không được hoàn nguyên vắc xin.

Hướng dẫn chuẩn bị Arexvy:

Yêu cầu hoàn nguyên Arexvy trước khi tiêm.

1. Rút toàn bộ thành phần trong lọ chứa hỗn dịch vào bơm tiêm.
2. Bơm toàn bộ thành phần trong bơm tiêm vào lọ chứa bột.
3. Lắc kỹ cho đến khi bột hòa tan hoàn toàn.

Vắc xin sau hoàn nguyên là một chất lỏng đục, từ không màu đến nâu nhạt.

Nên kiểm tra vắc xin sau hoàn nguyên bằng mắt thường xem có bất kỳ phân tử lạ và/hoặc biến đổi nào về mặt vật lý hay không. Nếu có, không được sử dụng vắc xin.

Nên sử dụng vắc xin ngay sau khi hoàn nguyên; nếu không thể sử dụng ngay, phải bảo quản vắc xin trong tủ lạnh (2°C-8°C) hoặc ở nhiệt độ phòng không quá 25°C. Loại bỏ vắc xin nếu không sử dụng trong vòng 4 giờ.

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở.

Cơ sở sản xuất:

Sản xuất, đóng gói cấp 1 kháng nguyên RSVPreF3 bởi: **GlaxoSmithKline Biologicals SA**, Parc de la Noire Epine – Avenue Fleming 20, Wavre, 1300, Belgium/ Bỉ

Sản xuất, đóng gói cấp 1 chất bổ trợ AS01E, đóng gói cấp 2 thành phẩm bởi: **GlaxoSmithKline Vaccines S.r.l**, Bellaria-Rosia-53018 Sovicille (SI), Italia/ Ý

Xuất xưởng bởi: **GlaxoSmithKline Biologicals SA,** Rue de l'Institut 89, Rixensart, 1330, Belgium/ Bỉ

Nhãn hiệu sở hữu bởi hoặc cấp phép cho GSK group of companies.

Số phiên bản: GDS 02. Ngày phát hành: 24 tháng 05 năm 2023

ARE 1023 – GDS02/240522